6.8 EQUIPAMIENTO DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

El equipamiento de la UPSS Cuidados Intensivos se implementa conforme a las Normas Técnicas de Salud: NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención" y su modificatoria, y la NTS N° 119-MINSA/DIGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención" y su modificatoria, o las que hagan sus veces, las que regulan lo mínimo que debe tener la UPSS Cuidados Intensivos.

6.8.1 SISTEMA DE AMBIENTALY ACÚSTICO.

a) El nivel de ruido ambiental se limita a 35 dB durante la mañana, 30 dB durante la tarde y 20 dB durante la noche. Para alcanzar estos niveles las señales de alarmas antes citadas se modulan. Las decisiones sobre los materiales de acabados (suelos, paredes y techos) deben disponer de una alta absorción acústica.
b) Regulación de la luz.
c) Sonido ambiental agradable.

6.8.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN.

a) La UPSS Cuidados Intensivos de cada establecimiento de salud dispone de servicios de comunicación como, telefonía fija, anexos telefónicos, internet inalámbrico (WI-FI), radio, en forma permanente para el registro de la data en tiempo real. Una vez que se disponga de Historia Clínica Electrónica, se dispone de los equipos de cómputo necesarios para este proceso.

b) El establecimiento de salud proporciona medios de comunicación al profesional de salud de su UPSS Cuidados Intensivos, garantizando la comunicación las 24 horas del día.

c) El equipamiento informático para resguardo de la data de la Historia Clínica del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos, incluye los datos del paciente por anamnesis, scores y examen físico y data directamente captada del soporte biomédico (ventiladores mecánicos, monitores hemodinámicos, neurológicos, entre otros) instalados, en y para el paciente, en tiempo real.

d) Para la implementación de un sistema de información en la UPSS Cuidados Intensivos de cada establecimiento de salud, se cuenta con la evaluación, en conjunto, de la parte médica involucrada, a través de un equipo designado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, así como del personal de la Oficina de Estadística e Informática, o quien haga sus veces, para la generación de un tablero de mando de indicadores de calidad de la UPSS Cuidados Intensivos para el monitoreo de la gestión de la calidad en Cuidados Intensivos.

e) El Ministerio de Salud, en el ejercicio de su rol de Autoridad Nacional de Salud, regula, supervisando y sancionando, según corresponda, y garantiza el cumplimiento del derecho constitucional y fundamental de la protección de los Datos Personales de Salud - DPS de los usuarios de los servicios de salud, públicos, privados y mixtos.

f) La generación de inteligencia estratégica de datos, mediante tableros de mando con la información de las UPSS Cuidados intensivos de cada establecimiento de salud, en relación a sus indicadores de calidad, proceso, estructura y grado de cumplimiento de guías de práctica clínica para la atención de pacientes, debe ser reportado trimestralmente a la Autoridad Nacional de Salud, para el benchmarking entre las Unidades Productoras de Servicios de Salud de Cuidados Intensivos a nivel nacional y la adopción sistemática de las mejores prácticas en Cuidados Intensivos.

C. ALVARADO CH.

6.9 HUMANIZACIÓN

En la UPSS de Cuidados Intensivos se establecen estrategias para la Humanización de la atención centrada en la persona; además, se fomenta las buenas relaciones interpersonales entre el personal de la UPSS Cuidados Intensivos y el paciente, entre el personal y la familia, y entre el mismo personal, en un ambiente físico adecuado que favorece esta interacción.

Las "puertas abiertas" en la UPSS Cuidados Intensivos considera:

a) **Permanencia y acompañamiento del familiar con el paciente, y la ampliación del horario de visitas**: que contribuye al bienestar del paciente, disminuye la ansiedad del familiar, y del paciente, aumenta la calidad de la atención percibida y satisface la necesidad de cercanía del paciente con su familiar y su pronta recuperación.

b) **Comunicación con el paciente intubado:** con respeto, esfuerzo, tiempo, interés y empatía con el paciente que tiene imposibilidad de expresarse y que sufre estrés por su condición.

c) **Flexibiliza la visita de familiares del paciente;** permite las visitas familiares infantiles, supeditadas a la condición clínica, condiciones de bioseguridad y a los deseos del paciente y el acompañamiento del familiar. En pacientes pediátricos el acompañamiento de los padres es permanente. Este criterio puede variar en caso de brotes, epidemias o pandemia.

d) **Incorpora a la familia en el cuidado del paciente:** la familia del paciente colabora en algunos cuidados, como el aseo personal, la administración de comidas o la estimulación de ejercicios de fisioterapia, bajo la supervisión del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos.

e) **Comunicación asertiva con escucha activa y participación en la toma de decisiones por parte del paciente:** profesionales de la salud informan al paciente, no solo al familiar o representante, acerca de su condición, tratamiento y decisiones, con empatía y respeto, para disminuir el estrés del paciente.

f) **Implementa mejoras para el bienestar ambiental:** regulación de la luz (antifaces), sonidos agradables (música ambiental), evitación de ruidos (tapones auditivos), acceso a equipos de comunicación (celular, teléfono, radio, televisión) que contribuyan a la orientación del paciente, y a la reducción de la incidencia de delirio; facilitando el descanso nocturno y la calidad de sueño del paciente y su bienestar.

g) **Otros aspectos:**

- ✓ Respeto a la privacidad del paciente y a su pudor, durante la higiene personal y la exploración clínica, tomando medidas para el cumplimiento de ello.
- ✓ Se evita la desnudez del paciente priorizando en todo momento el respeto a su intimidad.
- ✓ Dota de confort al familiar en la sala de espera: sillones, servicios higiénicos y cercanía a lugar de alimentación (cafetería), para disminuir la ansiedad e inducir a la colaboración de la familia con el personal de la UPSS Cuidados Intensivos y a la tranquilidad del paciente.
- ✓ El personal de la UPSS Cuidados Intensivos se comunican entre ellos con un bajo nivel de volumen de su voz, a fin de respetar al paciente y cuidarlo del estrés que está pasando.

C. ALVARADO CH.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1 NIVEL NACIONAL.

7.1.1 El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, es responsable de la difusión, asistencia técnica, así como de la evaluación de la implementación de la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional.

7.1.2 La Dirección General de Operaciones en Salud, dentro del marco de sus funciones, realiza la asistencia técnica para la implementación de la presente Norma Técnica de Salud.

7.1.3 La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), dentro del marco de sus funciones, realiza, la capacitación y certificación de los médicos cirujanos especialistas en medicina interna, cardiología, anestesiología, neumología y medicina de emergencias y desastres; y profesional en enfermería con título universitario.

7.2 NIVEL REGIONAL.

Las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana, las Direcciones Regionales de Salud y las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces en el nivel regional, son las responsables de la difusión, asistencia técnica, implementación y supervisión de la aplicación de la presente Norma Técnica de Salud en los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos de su ámbito territorial que cuentan con UPSS Cuidados Intensivos.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

7.3 NIVEL LOCAL.

El establecimiento de salud público, privado y mixto, que cuenta con UPSS Cuidados Intensivos, es responsable de la aplicación de lo dispuesto en la presente Norma Técnica de Salud.

VIII. ANEXOS

Anexo N° 1	:	Guías técnicas de los procedimientos médicos más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 2	:	Guías técnicas de intervención de enfermería según daños más frecuentes en la UPSS cuidados intensivos.
Anexo N° 3	:	Guías de práctica clínica de los daños más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 4	:	Indicadores de gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 5	:	Indicadores de calidad de la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 6	:	Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categoría II-2.
Anexo N° 7	:	Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categorías III-1, III- 2, III E.
Anexo N° 8 A	:	Parámetros clínicos con potencial recuperabilidad en pacientes en estado crítico adultos.
Anexo N°8B	:	Criterios pediátricos de admisión a la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 9	:	Prioridades de admisión a la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 10	:	Herramientas para los procesos de admisión y asignación de recursos en la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N°11	:	Recomendaciones generales en condiciones de sobredemanda en la UPSS Cuidados Intensivos causada por emergencia masiva o desastre

Anexo N°12	:	Registro diario de actividades y procedimientos médicos en la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N°13	:	Instructivo para el llenado de la hoja de registro diario de actividades y procedimientos médicos de la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 14	:	Modelo de formato de Junta Médica de la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 15	:	Consideraciones para la Nota de egreso de la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 16	:	Principales prestaciones de salud de la cartera de servicios de salud del establecimiento de salud que se llevan a cabo en la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 17	:	Principales procedimientos médicos que se llevan a cabo en la UPSS Cuidados Intensivos.
Anexo N° 18	:	Sistema de atención escalonado o piramidal para uso en casos de estado de emergencia nacional, de emergencia sanitaria o debido a una crisis sanitaria por Pandemia.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intervenciones Prestacionales
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 1

GUÍAS TÉCNICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS MÁS FRECUENTES EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

N°	Procedimientos Básicos (B) y Avanzados (A) que deben tener Guías Técnicas		II-2	III-1	III-2
1	Acceso y cateterización arterial para colocación de catéter.	B	X	X	X
2	Acceso y cateterización venosa central para colocación de catéter.	B	X	X	X
3	Asistencia al gran quemado en estado crítico.	A		X	X
4	Cardioversión sincronizada y desfibrilación.	B	X	X	X
5.	Colocación de catéter venoso central.	A	X	X	X
6	Colocación de catéter arterial.	B	X	X	X
7	Colocación de catéter de presión y perfusión intracraneal en el paciente en estado neuro crítico.	A		X	X
8	Colocación de marcapasos temporal.	A	X	X	X
9	Control y mantenimiento de nutrición artificial parenteral y soporte metabólico complejo.	A	X	X	X
10	Control y mantenimiento de nutrición enteral en el paciente en estado crítico.	A	X	X	X
11	Control y tratamiento de la arritmia grave.	B	X	X	X
12	Fibrobroncoscopía diagnóstica y terapéutica.	A	X	X	X
13	Intubación Endotraqueal.	B	X	X	X

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

N°	Procedimientos Básicos (B) y Avanzados (A) que deben tener Guías Técnicas		II-2	III-1	III-2
14	Manejo de las descompensaciones hidroelectrolíticas, endocrinas y del equilibrio ácido / base del paciente en estado crítico.	B	X	X	X
15	Manejo de vía aérea artificial difícil.	A	X	X	X
16	Mantenimiento del donante de órganos.	A		X	X
17	Mantenimiento y control del paciente Postrasplantado.	A		X	X
18	Monitorización computarizada de trastornos de ritmo cardíaco.	B	X	X	X
19	Monitorización de la función ventilatoria y de intercambio gaseoso.	B	X	X	X
20	Monitorización de mecánica ventilatoria invasiva y no invasiva.	A	X	X	X
21	Monitorización hemodinámica y de perfusión tisular.	B	X	X	X
22	Monitorización neuro crítica con Doppler transcraneal.	A		X	X
23	Monitorización neuro crítica con presión intracraneal.	A	X	X	X
24	Monitorización y tratamiento de la cardiopatía isquémica aguda con insuficiencia cardiaca.	B	X	X	X
25	Punción y drenajes torácico, pericardio y abdominal en el paciente en estado crítico.	A	X	X	X
26	Soporte dialítico.	A		X	X
27	Transporte asistido del paciente en estado crítico a nivel interinstitucional.	B	X	X	X
28	Transporte interno asistido del paciente en estado crítico (dentro del establecimiento de salud).	B	X	X	X
29	Traqueostomía percutánea.	A	X	X	X

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

N°	Procedimientos Básicos (B) y Avanzados (A) que deben tener Guías Técnicas		II-2	III-1	III-2
30	Traqueostomía quirúrgica.	A	X	X	X
31	Tratamiento fibrinolítico en el paciente en estado crítico.	A	X	X	X
32	Valoración e interpretación de ultrasonografía en medicina intensiva.	A	X	X	X

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 2

GUÍAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN DAÑOS MÁS FRECUENTES EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

N°	Intervenciones de Enfermería en la UPSS Cuidados Intensivos a tener en Guías Técnicas	II-2	III-1	III-2
1	Administración de NET (nutrición enteral).	X	X	X
2	Asistencia en colocación de catéter venoso central.	X	X	X
3	Asistencia en intubación endotraqueal.	X	X	X
4	Asistencia para ventilación prona.	-	X	X
5	Aspiración de secreciones en paciente con vía aérea artificial.	X	X	X
6	Curación y mantenimiento de catéter venoso central.	X	X	X
7	Medición de balón de neumotaponamiento.	-	X	X
8	Medición de PIA (presión intrabdominal).	X	X	X
9	Medición de PIC con set de drenaje ventricular externo (DVE).	X	X	X
10	Medición de presión arterial invasiva.	X	X	X
11	Preparación de drogas inotrópicas.	X	X	X

C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 3

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS DAÑOS MÁS FRECUENTES EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Guías de Práctica Clínica (GPC) de implementación obligatoria en la UPSS Cuidados Intensivos
1. GPC de Shock Circulatorio.
2. GPC de Sepsis y Shock Séptico.
3. GPC de Insuficiencia Respiratoria Aguda.
4. GPC de Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto.
5. GPC de Traumatismo Encéfalo Craneano Grave.
6. GPC de Pancreatitis Aguda Grave.
7. GPC de Síndrome Coronario Agudo.
8. GPC de Tromboembolismo Arterial y/o Venoso.
9. GPC de Falla Intestinal.
10. GPC de Muerte Encefálica, Donación y Trasplante de Órganos.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales C. ALVARADO CH.

Según apliquen las anteriores y adicionalmente para la unidad de cuidados intensivos neonatales se obliga a:

11. GPC de Enfermedad de Membrana Hialina.
12. GPC de Ductus Arterioso Persistente.
13. GPC de Manejo del Prematuro de Menos de 1500 gramos.
14. GPC de Gastrosquisis.
15. GPC de Onfalocele.
16. GPC de manejo del dolor.

- Otras Guías de Práctica Clínica que se apliquen por especialidades, y según condición y patología del paciente

ANEXO N° 4

INDICADORES DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
Promedio mensual de Permanencia N° de días de hospitalización en la unidad/ N° total de egresos por mes	Número de días promedio que permanecen los pacientes en la UPSS Cuidados Intensivos en un tiempo determinado. El número de días hospitalizado solo se cuentan para pacientes egresados, al momento del cálculo no se toman en cuenta los días de los pacientes aún hospitalizados.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería.	6 – 8 días	Permite evaluar junto con otros indicadores, la calidad de los servicios prestados y el aprovechamiento del recurso cama.
Porcentaje de Ocupación Cama /mes Total, de pacientes-días x 100 /Total de días camas disponibles por mes	Pacientes-días: Número de pacientes que ocupan las camas de la UPSS Cuidados Intensivos en un día calendario. Se obtiene del conteo del censo diario. Días camas disponibles: Total de camas habilitadas para hospitalización, ocupadas o vacantes en cada día, se obtiene del conteo diario.	Mensual	Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería, Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	90%	Mide el grado de ocupación de cada cama hospitalaria.
Rendimiento Cama/mes Total, de egresos/	Relación entre el número de egresos de la UPSS Cuidados Intensivos registrados en un período de tiempo y el número de camas	Mensual	Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería, Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión	4 – 5 /mes	Mide el rendimiento de una cama durante un periodo determinado de tiempo, es decir los egresos que ha producido en el periodo.

C. ALVARADO CH.

INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
N° total de camas disponibles promedio por mes	promedio registrados en el mismo periodo.		clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.		
Intervalo de sustitución mensual Días camas disponible–paciente días/ N° total de egresos por mes	Indicador que se obtiene relacionando la diferencia de los días camas disponibles y pacientes días de un determinado periodo de tiempo con respecto al número de egresos hospitalarios en el mismo periodo de tiempo.	Mensual	Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería, Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	1	Mide el tiempo en que permanece la cama vacía, entre un egreso y el subsiguiente ingreso en la misma cama. Promedios altos indican poca demanda u otros problemas organizativos. Junto con el promedio de permanencia, el porcentaje de ocupación y el rendimiento cama dan una visión panorámica de la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.
Tasa de mortalidad Bruta **(N° de defunciones en UCI en un período / N° de egresos de UCI en el mismo periodo) x 100**	Es la proporción de fallecidos en dicho servicio respecto al total de egresos durante el mismo período, sin considerar las muertes que ocurrieron antes o después de las 48 horas de ingresado el paciente.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería.	< 30%	Sirve para mantener una apreciación global de la situación de mortalidad de los pacientes en UCI, sin que se pueda discriminar las causas relacionadas con el estado de salud de los pacientes de las asociadas a la calidad de los servicios de salud.
Tasa de mortalidad Neta **(N° de fallecidos en UCI después de 48 horas de su admisión en un**	Es la proporción de fallecidos en dicho servicio respecto al total de egresos en UCI durante un mismo período,	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y Profesional en	< 5%	Sirve para evaluar la calidad de atención que se brinda a los pacientes de UCI, permitiendo un mayor nivel de precisión que

C. ALVARADO CH.

INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
período / N° de egresos de UCI en el mismo período) x 100	considerando sólo las muertes que ocurrieron después de las 48 horas de ingresado el paciente.		enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería.		la tasa de mortalidad bruta, ya que se presume que las muertes ocurridas están asociadas con la atención hospitalaria.
Porcentaje de utilización de ventiladores **(N° de horas diarias de utilización de ventiladores en un período / N° de horas disponibles de utilización de ventiladores en el mismo período) x 100**	Es el tiempo que cada ventilador mecánico está en funcionamiento, entre el tiempo de funcionamiento estandarizado para que cada equipo que se encuentre operativo, cumpla con el volumen de trabajo que le corresponde.	Mensual	Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería o profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de turno.	40% a 60%	Sirve para establecer el grado de utilización de los ventiladores de la UCI. La diferencia entre la máxima capacidad instalada y el grado de utilización, permite establecer la capacidad instalada ociosa.
Porcentaje de Neumotórax producidos por Cateterismo **N° de pacientes con neumotórax producidos por CVC en un período / N° de pacientes con CVC en el mismo período**	Es la suma de todos aquellos que, debido a la colocación de un catéter venoso central, presentan un cuadro de neumotórax. No se consideran el neumotórax que se origina como parte de la evolución de una enfermedad.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería.	< 15%	Este indicador evalúa la calidad de la atención en UCI, respecto a la inserción de catéteres en los pacientes.
Promedio de score TISS Promedio del score TISS de todos los egresos mensuales	Evalúa el promedio de los valores de TISS en los egresos del mes.	Mensual	Profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería o profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de turno.	Varía de acuerdo al nivel de complejidad.	Evalúa el grado de intervención de enfermería que requieren los pacientes. Permite una comparación estandarizada para los indicadores entre diferentes UCI.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Gestión e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
Promedio de Apache II Promedio del score APACHE II evaluado al ingreso de todos los egresos mensuales	Evalúa el promedio de los valores de APACHE II en los egresos del mes.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia, Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	Varía de acuerdo al nivel de complejidad	Evalúa el grado de severidad y pronóstico de los pacientes ingresados a la UPSS Cuidados Intensivos y permite una comparación estandarizada para los indicadores entre diferentes UPSS Cuidados Intensivos.
Promedio de score SOFA Promedio del score SOFA al ingreso, de todos los egresos mensuales	Evalúa el promedio de los valores de SOFA en los egresos del mes.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia.	Varía de acuerdo al nivel de complejidad.	Evalúa el grado de severidad y pronóstico de los pacientes ingresados a UCI y permite una comparación estandarizada para los indicadores entre diferentes UCI.
Promedio mensual de pacientes en estado crítico en lista de espera para ingreso a UPSS CI Pacientes en estado crítico con indicación de ingreso a UPSS Cuidados Intensivos en lista de espera que no logran acceder por turno/ Número total de pacientes con indicación de ingreso a UPSS Cuidados Intensivos por mes	Determina grado de sobredemanda de áreas críticas en condiciones regulares y de emergencia sanitaria.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia.	Varía de acuerdo al nivel de complejidad.	Evalúa la capacidad resolutiva real para manejo de pacientes en estado crítico del establecimiento de salud. Debe reportarse en forma diaria y mensual a la DIRIS/DIRESA/GERESA, según corresponda, para toma de acciones correspondientes.
Promedio mensual de tiempo de acceso de pacientes en estado crítico a la UPSS Cuidados Intensivos Tiempo (en horas) de demora del ingreso del paciente a UPSS	Determina tiempo en horas de demora del paciente a áreas críticas en condiciones regulares.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos	Varía de acuerdo al nivel de complejidad.	Evalúa la capacidad operativa real para ingreso de pacientes en estado crítico del establecimiento de salud.

C. ALVARADO CH.

INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
Cuidados Intensivos desde que se indica en la respuesta de una interconsulta / Hora de indicación de ingreso a UPSS Cuidados Intensivos			y médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia		
Promedio mensual pacientes en estado crítico que no logran ingresar a la UPSS Cuidados Intensivos Número de pacientes en estado crítico con indicación de ingreso a UPSS Cuidados Intensivos que no logran ingresar, por turno/ Número total de pacientes con indicación de ingreso a UPSS Cuidados Intensivos por mes	Determina número de pacientes en estado crítico que no logra ingresar a UPSS Cuidados Intensivos	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos	Varía de acuerdo al nivel de complejidad	Evalúa la capacidad operativa y resolutiva del Establecimiento de Salud.

- Adicionalmente se incluyen Scores e indicadores propios de la especialidad a la que se dedican las unidades de cuidados intensivos de especialidades, según corresponda.

C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 5

INDICADORES DE CALIDAD DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
De Estructura	**Presencia de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos 24 horas** N° de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos titulados programados al mes x 100/N° total de Profesional en Enfermería programado al mes.	Porcentaje de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos programado mensualmente.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	> 7 0 % para establecimiento de salud categoría II-2 en Regiones. > 8 0 % para establecimiento de salud categoría III-1 en Regiones. 100% para establecimiento de salud categoría III-1, III-2 en la ciudad de Lima.	Porcentaje debe llegar a 100% cuando se cubra la oferta de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos a nivel nacional en forma progresiva y sistemática.
	Porcentaje de equipos biomédicos con mantenimiento preventivo N.º de equipos biomédicos con mantenimiento preventivo x 100 / N.º de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos en mantenimiento preventivo de la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.
	Porcentaje de equipos biomédicos con mantenimiento correctivos N.º de equipos biomédicos con mantenimiento correctivo x 100 / N.º de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos en mantenimiento correctivo de la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Porcentaje de equipos biomédicos con mantenimiento de calibración N.° de equipos biomédicos con mantenimiento de calibración x 100 / N.° de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos en mantenimiento de calibración de la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.
	Porcentaje de equipos biomédicos operativos N.° de equipos biomédicos operativos x 100 / N.° de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos operativos en la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.
De proceso	**Porcentaje de eventos adversos analizados** N.° Eventos Adversos analizados x 100/ N.° de Eventos Adversos ocurridos	Porcentaje de eventos adversos registrados, que tengan análisis causal y planteamiento de mejora en cada año (registro, notificación y gestión: análisis para mejora) en la UPSS Cuidados Intensivos.	Anual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	100%	Permite medir la cantidad de eventos adversos analizados y toma de acciones respectivas.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Asesoramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Porcentaje de adherencia a guías de práctica clínica y/o protocolos. Número de Historias Clínicas auditadas que cumplen con las recomendaciones de manejo de la Guías de práctica clínica y/o protocolos, según patología priorizada x 100 /Total de Historias Clínicas de pacientes con patología priorizada que recibieron manejo	Porcentaje de pacientes que son atendidos cumpliendo las Guías de práctica clínica y/o protocolos en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	100%	Permite medir si la atención del paciente en estado crítico es adecuada a las Guías de práctica clínica y/o protocolos.
	Densidad de incidencia de Neumonía asociada a ventilador mecánico (VM) Número de casos de Neumonía asociada a VM x 100/ Total, de días de exposición al ventilador mecánico	Indicador que mide la cantidad de neumonías asociadas a los días de exposición del ventilador mecánico.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	<5 x 1000 días VM (II-2); < 7 x 1000 días VM (III-1, III-2)	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.
	Densidad de incidencia de infección asociada a Catéter Venoso Central (CVC) Número de casos de Infección por CVC x 100/ Total, de días de exposición al CVC	Indicador que mide la cantidad de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a los días de exposición al catéter venoso central.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	< 6 x 1000 días CVC (II-2) < 7 x 1000 días CVC (III-1, III-2)	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Densidad de incidencia de infección asociada a catéter urinario Número de casos de infección urinaria x 100/ Total, de días de exposición a la sonda urinaria	Indicador que mide la cantidad de infecciones urinarias asociadas a los días de exposición de la sonda urinaria.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	< 4 x 1000 días catéter urinario	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.
	Porcentaje de retiro accidental de catéteres vasculares (CV) N.° de CV retirados accidentalmente x 100 / N ° de días de CV por pacientes hospitalizados por mes	Porcentaje de catéteres vasculares que son retirados accidentalmente por el personal en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	Catéter arterial: 15 catéteres por 1000 días CVC y CVP: 06 catéteres por 1000 días	El retiro accidental de catéteres afecta de manera directa a la seguridad del paciente, supone un aumento del riesgo de complicaciones.
	Incidencia de lesiones por presión (LPP) grado 3 o 4 Número de UPP que se producen x 1000/Número de estancias.	En la implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente este indicador mide el porcentaje de lesiones por presión desarrolladas en pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	0%	La utilización de protocolos relacionados con la seguridad del enfermo y medidas de restricción puede disminuir su incidencia.
	Incidencia de errores de medicación discriminando por medicamentos de alto riesgo y otros. N.° total de errores de medicación comunicados x 100 /N.° total de administraciones de medicación.	En la implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente este indicador mide el Porcentaje de errores de administración de medicamentos comunicados en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería	0%	Los errores de medicación son los incidentes más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos y se asocian a un incremento de la morbilidad, mortalidad, estancia y costes.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Razón de eventos adversos centinela por egresos hospitalarios de la UPSS Cuidados Intensivos Numero de eventos adversos por egreso x 100 / Total de egresos en el mismo período.	Relación entre los eventos adversos que presentan los pacientes que egresan de la UPSS Cuidados Intensivos y el total de los egresos de los pacientes.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	< 4	Su valor permite evaluar las complicaciones o eventos adversos que presentan los pacientes que egresan de la UPSS Cuidados Intensivos y conocer los factores intrínsecos, extrínsecos que están presentes en la aparición de éstos, a fin de tomar medidas para evitarlos y la disminuir su gravedad.
De Resultados	**Razón de mortalidad estandarizada en la UPSS Cuidados Intensivos o Mortalidad indexada al APACHE II** Mortalidad neta (fallecidos post 48 horas) x 100 / Total, de pacientes admitidos en el mismo período Mortalidad esperable por APACHE II en el mismo periodo de tiempo	Relación entre la Mortalidad neta de la UPSS Cuidados Intensivos y la mortalidad esperable del paciente según su riesgo de muerte a la admisión (dada por el score pronóstico APACHE II). Fuente de dato: Registro de Score APACHE II.	Mensual.	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	< 1.1	Su valor permite la comparación entre las diferentes UPSS de Cuidados Intensivos del mismo tipo de otros hospitales. Se espera que ambas tasas sean muy parecidas. De ser mayor el estándar, reflejaría un exceso de mortalidad para lo esperable.
	Porcentaje de pacientes con lesiones por flebitis (N° de pacientes hospitalizados con flebitis en un período / N° de pacientes hospitalizados en UCI con catéter	Porcentaje de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos, que tienen lesiones por flebitis.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	< 15%	Mide la calidad de la intervención de enfermería respecto a la correcta aplicación de catéteres venosos periféricos

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General
C. ALVARADO T.H

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	venoso periférico en el mismo período) x 100					(venoclisis), en pacientes hospitalizados en UCI.
	Mortalidad oculta o mortalidad de los egresos de la UPSS Cuidados Intensivos hasta las 72 horas, indexada al APACHE II. Mortalidad oculta o de los egresos de la UPSS Cuidados (fallecidos post 72 horas) x 100 / Total, de pacientes egresados en el mismo período.	Relación entre la Mortalidad de los egresos de la UPSS Cuidados Intensivos versus la mortalidad esperable del paciente según su riesgo de muerte al egreso.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.		Su valor permite evaluar las características de los pacientes tales como comorbilidades asociadas, parámetros fisiológicos y bioquímicos diferentes entre los pacientes que egresaron de la UPSS Cuidados Intensivos que vivieron y los que fallecieron.
	Reingreso a la UPSS Cuidados Intensivos N.° de pacientes que salieron de la UPSS CI que son reingresados dentro de las 48 horas de su salida de la UPSS CI x 100/ N.° total de egresos	Porcentaje de pacientes que regresan a la UPSS Cuidados Intensivos dentro de las 48 horas desde la salida de ésta.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva	4 a 14%	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.
	Porcentaje de caídas del paciente Número de caídas que se producen x 100/Número de estancias.	En la implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente este indicador mide el porcentaje de caídas de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	0%	Las caídas accidentales pueden provocar lesiones a los enfermos, además de influir negativamente en la calidad percibida. Es un evento evitable.
	Demanda Insatisfecha en Cuidados Intensivos	Porcentaje de pacientes en estado crítico con indicación de manejo en la UPSS		Médico cirujano especialista en	0%	Mide la efectividad de la gestión hospitalaria para poder solucionar la

C. ALVARADO CH.

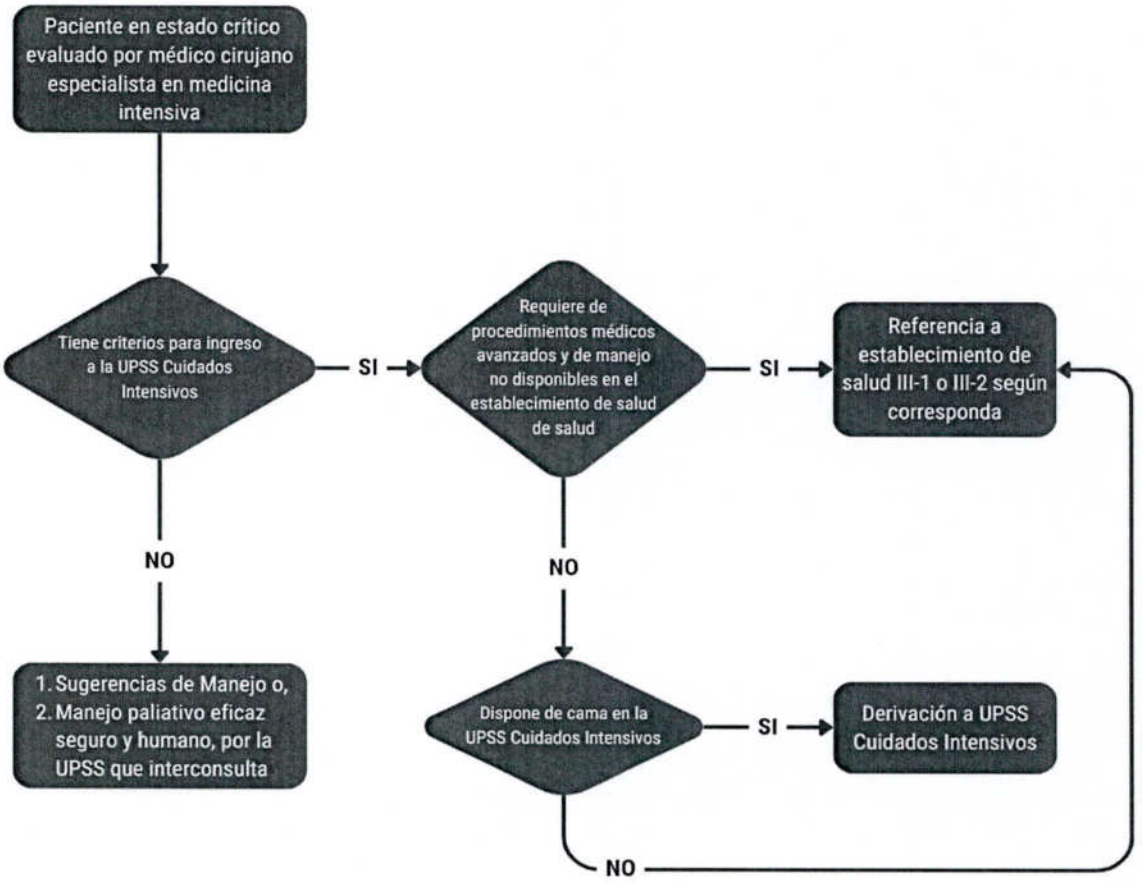
TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	N.° de pacientes que NO ingresan a la UPSS Cuidados intensivos por falta de camas x 100/ Número total de pacientes con indicación de ingreso	Cuidados Intensivos (Unidad de Cuidados Intensivos e Unidad de Cuidados Intermedios) pero que no pueden acceder por falta de camas. Fuente de dato: Registro de Interconsultas.	Por turno de 12 horas.	medicina intensiva de turno, o guardia.		continuidad de la atención. Su medición a este nivel permite medir la Gestión hospitalaria en su conjunto.
	Número de familiar o representante de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos que reciben informe médico de acuerdo con la directiva del establecimiento de salud Número de familiar o representante por paciente hospitalizado en la UPSS Cuidados Intensivos que recibe/n informe x 100/ Número total de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos por mes	Porcentaje de familiar o representante de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos que reciben informe médico	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	100%	Información que se brinda a familiar del paciente a fin del conocimiento de su evolución y pronóstico

- Adicionalmente se incluyen Scores e indicadores propios de la especialidad a la que se dedican las unidades de cuidados intensivos de especialidades, según corresponda.

MINISTERIO DE SALUD
Aseguramiento y Prestaciones
Dirección General de
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 6

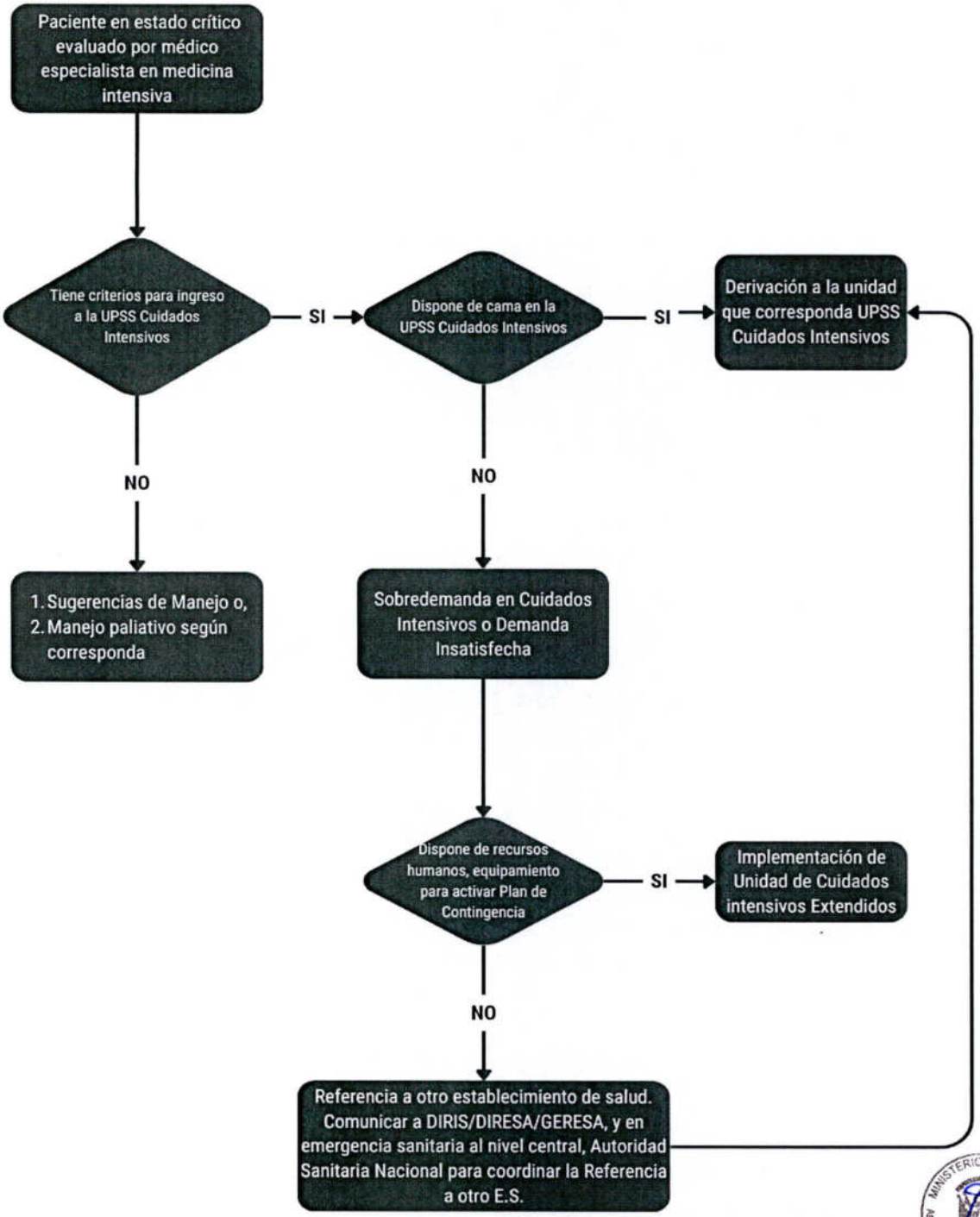
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORÍA II- 2



MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 7

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORÍAS III-1, III-2, III-E.



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacional
C. ALVARADO CH.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 8A

PARÁMETROS CLÍNICOS CON POTENCIAL DE RECUPERABILIDAD EN PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO ADULTOS[5]

A. Sistema Cardíaco

- Infarto Agudo de Miocardio con complicaciones.
- Shock cardiogénico.
- Arritmias complejas que requieren monitoreo cercano e intervención.
- Insuficiencia cardiaca congestiva aguda con falla respiratoria y/o que requiera soporte hemodinámico.
- Emergencias hipertensivas.
- Angina inestable, particularmente con disritmias, inestabilidad hemodinámica o dolor torácico persistente.
- Cuidados inmediatos del síndrome post paro cardiaco.
- Taponamiento cardiaco o constricción con inestabilidad hemodinámica.
- Pre y post quirúrgico de Aneurisma disecante de aorta.
- Bloqueo A-V completo.

B. Sistema pulmonar

- Insuficiencia respiratoria aguda con indicación de soporte con alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o invasiva.
- Embolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica.
- Deterioro respiratorio de pacientes en unidades de cuidados intermedios con criterios de recuperabilidad.
- Hemoptisis masiva.

C. Desórdenes Neurológicos

- Enfermedad cerebrovascular aguda con alteración del estado mental.
- Coma: Metabólico, tóxico o anóxico.
- Hemorragia intracraneana.
- Hemorragia subaracnoidea aguda.
- Vasoespasmo cerebral.
- Traumatismo encéfalo craneano severo.
- Meningitis con alteración del estado mental o compromiso respiratorio.
- Desorden del sistema nervioso central o desorden neuromuscular con deterioro neurológico o de la función pulmonar.
- Estado epiléptico.
- Muerte encefálica potencial donante.

D. Tóxicos: Ingestión de drogas y sobredosis

- Ingestión de drogas que conllevan a inestabilidad respiratoria y/o hemodinámica.
- Ingestión de drogas que alteran significativamente el estado mental y con inadecuada protección de vía aérea.
- Convulsiones post-ingesta de ingestión de drogas.

C. ALVARADO CH.

E. Desórdenes Gastrointestinales

- Hemorragia gastrointestinal complicado con hipotensión arterial, compromiso de vía aérea, angina o comorbilidades.
- Insuficiencia hepática fulminante.
- Pancreatitis severa o con factores de riesgo para complicación a severa.
- Perforación esofágica con o sin mediastinitis.

F. Endocrinológicos

- Cetoacidosis diabética complicada con inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria aguda que amerite soporte ventilatorio artificial.
- Tormenta tiroidea o coma mixedematoso con inestabilidad hemodinámica.
- Estado hiperosmolar con coma y/o inestabilidad hemodinámica.
- Otros problemas endocrinos tales como crisis adrenales con inestabilidad hemodinámica.
- Hipercalcemia severa con estado mental alterado que requiere monitoreo hemodinámico.
- Hipo o hipernatremia con convulsiones, estado mental alterado.
- Hipo o hiperpotasemia con disritmia o con debilidad muscular.

---

[5] Referenciales.

- Hipo o hipermagnesemia con compromiso hemodinámico o disritmia.
- Hipofosfatemia con debilidad muscular y riesgo de insuficiencia respiratoria.

G. Quirúrgicas

- Post-operados de alto riesgo de complicaciones que requieren monitoreo hemodinámico u orgánico, soporte ventilatorio o cuidados de enfermería.
- Post-operados de emergencia.
- Post-operados electivos complicados en salas de operaciones o en salas de recuperación anestésica.

H. Infecciosos

- Shock séptico.
- Sepsis severa que precisa monitoreo hemodinámico.
- Insuficiencia respiratoria aguda inusitada para ambiente de aislamiento.
- Proceso infeccioso generalizado en proceso de estudio que precisa manejo de soporte ventilatorio o hemodinámico.
- Dengue Grave.
- Malaria Grave.

I. Misceláneas

- Condiciones clínicas con parámetros fisiológicos alterados según lo descrito en el punto J.
- Injurias ambientales (electrocución, ahogamiento, hipo/hipertermia).
- Terapias nuevas/experimentales con complicaciones que potencialmente comprometen o ponen en riesgo la vida del paciente.
- Shock anafiláctico.
- Quemadura que toma > 10% del área de superficie corporal.
- Referencias de pacientes en estado crítico de establecimientos con unidades con sobresaturación de cuidados intensivos hacia otra unidad con camas UCI disponibles.
- Gestantes que cumplen criterios de riesgo y severidad según la norma técnica para la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extreman vigente.

J. Parámetros fisiológicos

Signos clínicos:

- Frecuencia cardiaca < 50 o > de 150 latidos/minuto.
- Presión arterial sistólica < 90 mmhg o variación de 20 mmhg debajo de la presión usual del paciente.
- Frecuencia respiratoria > 25 respiraciones/minuto. *
- Escala de coma de Glasgow < 14.
- Saturación < 90

Valores de laboratorio:

- Lactato > 2.5 mmol/L.
- Sodio sérico < 110 meq/L o > 170 meq/L.
- Potasio sérico < 2 meq/L o > 7 meq/L.
- Pa02 < 50 mmhg.
- pH < 7.2 o > 7.7
- Glucosa sérica > 700 mg/dl.
- Calcio sérico > 15 mg/dl.
- Niveles tóxicos de drogas u otras sustancias químicas en un paciente hemodinámico o neurológicamente comprometido.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Inmunización Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 8B

CRITERIOS PEDIÁTRICOS DE ADMISIÓN A UCI[6]

Sistema Respiratorio

Pacientes con enfermedad pulmonar o de la vía aérea alta y baja grave, potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Intubación endotraqueal o potencial necesidad de intubación endotraqueal de emergencia y de ventilación mecánica, independientemente de la etiología
2. Enfermedad pulmonar grave rápidamente progresiva o de la vía aérea inferior o superior, con riesgo de progresión a fallo respiratorio y/o a obstrucción total
3. Elevados requerimientos de oxígeno suplementario (FiO2 ≥ 0,5), independientemente de la etiología
4. Realización reciente de traqueostomía con o sin necesidad de ventilación mecánica (si hay descompensación de su estado basal)
5. Barotrauma agudo que compromete la vía aérea inferior o superior
6. Requerimiento de medicaciones nebulizadas o aerosolizadas con más frecuencia de lo que puede ser administrado con seguridad fuera de la UPSS Cuidados Intensivos de acuerdo con las guías de la institución (no siendo obligatoria sino hay descompensación).
7. Pacientes que requieren asistencia respiratoria extracorpórea: ECMO veno-venoso o veno-arterial, eliminación extracorpórea de CO2.
8. Ocupación del espacio pleural que compromete la respiración o produce inestabilidad hemodinámica requiriendo infusión de fluido o vasopresores si hay descompensación respiratoria o hemodinámica o de su estado basal)
9. Postoperatorio de tórax que requiera monitorización, ventilación u otra medida propia de UCI

Sistema Cardiovascular

Pacientes con enfermedad cardiovascular grave, potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Shock, independientemente de la etiología
2. Post-resucitación cardiopulmonar
3. Disritmias graves potencialmente letales (Incluye disritmia con inestabilidad hemodinámica).
4. Insuficiencia cardiaca congestiva inestable, con o sin necesidad de ventilación mecánica
5. Enfermedad cardiaca congénita con estado cardio-respiratorio inestable
6. Después de procedimientos intratorácicos y cardiovasculares de alto riesgo
7. Necesidad de monitorización invasiva continua de la presión arterial, venosa central,
1. de la arteria pulmonar o del gasto cardiaco
8. Necesidad de marcapasos cardiaco transitorio o permanente
9. Hipertensión arterial grave que requiere terapia Intravenosa
10. Pacientes que requieren soporte cardiocirculatorio extracorpóreo: ECMO, asistencia ventricular externa, balón de contrapulsación.
11. Taponamiento cardíaco establecido o inminente
12. Miocarditis agudas graves

Infeccioso

Pacientes con infección o sospecha de infección potencialmente letal. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Sepsis
2. Shock séptico con SDMO (Síndrome de Disfunción Multiorgánica o circulatoria)
3. Meningitis y/o encefalitis con deterioro del nivel de conciencia o manifestaciones sistémicas graves.
4. Infección o absceso que por su localización, extensión o estado clínico del paciente comprometan o puedan potencialmente comprometer gravemente el funcionamiento de al menos un órgano o sistema vital o de la vía aérea.
5. Infección grave en paciente con inmunosupresión de origen congénito o farmacológico, sepsis. Paciente inmunosuprimido con inestabilidad hemodinámica respiratoria y/o sepsis/shock séptico (según definición Sepsis 3 y valoración P-SOFA)

---

[6] El listado es referencial, sin ser una limitante para decisiones clínicas en base a la realidad particular del paciente pediátrico o neonato.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

6. Enfermedades infecciosas cuya conocida evolución natural y/o potenciales complicaciones sean potencialmente letales o amenacen la disfunción grave de al menos un órgano o sistema vital.

Neurológico

Pacientes con enfermedad neurológica actual grave, potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Convulsiones que no responden al tratamiento o que requieren infusión continua de agentes anticonvulsivantes, incluyendo el estatus epiléptico.
2. Pacientes con convulsiones que muestren inestabilidad de los signos vitales relacionados con la vía aérea, respiración o circulación.
3. Alteración aguda y/o grave del sensorio donde el deterioro o depresión neurológica es probable o impredecible, o coma con compromiso potencial de la vía aérea.
4. Tras procedimientos quirúrgicos que requieren monitorización invasiva u observación clínica estrecha y continuada; En caso de deterioro del Score Glasgow, es obligado en GCS menor de 9 (riesgo de control de vía aérea).
5. Inflamación o infecciones agudas de la médula espinal, meninges o cerebro que se acompañan de depresión neurológica, alteraciones metabólicas y hormonales, compromiso hemodinámico y/o respiratorio o del potencial incremento de la presión intracraneal.
6. Traumatismo encéfalo craneano grave y/o con incremento de la presión intracraneal
7. Cualquier condición preoperatoria neuroquirúrgica que se acompañe de deterioro neurológico.
8. Disfunción neuromuscular progresiva con o sin alteración del sensorio que requiera monitorización cardiovascular y/o soporte respiratorio
9. Compresión de la médula espinal establecida o inminente.
10. Colocación de un dispositivo para drenaje ventricular externo
11. Hemorragia intraventricular o edema cerebral evidenciado por imagen o en forma clínica.
12. Nuevo cambio pupilar, del nivel de conciencia, del estado mental o deterioro de la Graduación Glasgow del Coma.
13. Necesidad de monitorización de la presión intracraneal, saturación tisular cerebral y/o presión arterial continúa.
14. Ante la sospecha o diagnóstico de un accidente cerebrovascular agudo.

Hematología/oncología

Pacientes con enfermedad hematológica u oncológica grave, potencialmente letal o inestable o con sangrado activo que amenaza su vida. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Cualquier patología hematooncológica descompensada grave, sea por complicaciones del tratamiento específico o infecciones intercurrentes (sepsis, neutropenia febril alto riesgo)
2. Exanguíneo-tranfusiones
3. Plasmaféresis y leucoféresis con condición clínica inestable
4. Coagulopatía grave
5. Anemia grave que resulta en compromiso hemodinámico y/o respiratorio
6. Complicaciones graves de la crisis de células falciformes como cambios neurológicos, síndrome del tórax agudo o anemia aplásica con inestabilidad hemodinámica
7. Iniciación de quimioterapia con anticipación del síndrome de lisis tumoral
8. Masas o tumores que comprimen o amenazan con comprometer vasos vitales, órganos o la vía aérea.
9. Hiperleucocitosis que se acompañe de o implique un riesgo elevado de hiperviscosidad e hipertensión pulmonar.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

Endocrino/metabólico

Pacientes con enfermedad endocrina o metabólica grave, potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Cetoacidosis metabólica grave que requiere tratamiento que excede la capacidad institucional para el cuidado del paciente fuera de la UCIP (si existiera compromiso hemodinámico o neurológico ver la sección específica)
2. Otras Alteraciones hidroelectrolíticas o acido base con compromiso (hemodinámico, respiratorio o disfunción orgánica) del paciente tales como:
   - Hiperkalemia que requiere monitorización cardiaca e intervención terapéutica aguda.
   - Hipo- o hipernatremia
   - Hipo- o hiperglicemia que requiere monitorización intensiva
   - Acidosis metabólica grave que requiere infusión de bicarbonato, monitorización intensiva o intervención compleja
   - Situaciones clínicas con anormalidades agudas graves establecidas o potenciales de los iones divalentes: fósforo, calcio o magnesio

- Si se requiere una intervención compleja para mantener el balance de fluido

3. Errores congénitos del metabolismo con deterioro agudo que requiere soporte respiratorio, diálisis, hemofiltración, manejo de la hipertensión intracraneal o soporte inotrópico.
4. Insuficiencia suprarrenal de cualquier etiología que se acompañe de anormalidades electrolíticas y/o de disfunción cardiovascular que requiera soporte vasopresor.
5. Cualquier patología que involucre disfunción grave de alguno de los sistemas endocrinos y secundariamente a alteración grave de la homeostasis.

Gastrointestinal

Pacientes con enfermedad gastrointestinal grave, potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Sangrado gastrointestinal agudo grave que conduce a inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria
2. Después de una endoscopia de emergencia para extraer cuerpos extraños si hay inestabilidad en el paciente puede pasar a sala de observación.
3. Fallo hepático agudo que conduce o potencialmente pueda conducir a coma o inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria.
4. Pancreatitis aguda grave.

Quirúrgico

Pacientes postquirúrgicos en estado de enfermedad grave y/o que requieren monitorización continuada y/o que potencialmente requieran intervención o monitorización invasiva y/o que se acompañen o potencialmente se puedan acompañar de fallo o disfunción grave de al menos un órgano, aparato o sistema vital. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Cirugía cardiovascular mayor.
2. Cirugía torácica compleja.
3. Neurocirugía y procedimientos relacionados si hay descompensación o riesgo de ésta.
4. Cirugía mayor vía aérea - otorrinolaringológica- maxilofacial - plástica
5. Cirugía ortopédica y columna si hay descompensación o riesgo de esta o según complejidad de la misma.
6. Cirugía general que se acompañe de inestabilidad respiratoria y/o hemodinámica
7. Trasplante de órganos
8. Politraumatizados - Gran Quemado
9. Pérdida sanguínea masiva ya sea durante la cirugía o durante el periodo postoperatorio
10. Trauma múltiple con o sin inestabilidad cardiovascular y con o sin necesidad de cirugía.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacional
C. ALVARADO CH.

Sistema Renal

Pacientes con enfermedad renal grave, potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Fallo renal agudo.
2. Pacientes que requieren hemodiálisis aguda, diálisis peritoneal u otras terapias de remplazamiento renal como la hemofiltración o hemodiafiltración veno-venosa continua en un paciente inestable o paciente crónico descompensado.
3. Rabdomiólisis aguda con insuficiencia renal

Afectación multisistémica, multiorgánica y otros

Pacientes con enfermedad multisistémica o multiorgánica grave o potencialmente letal o inestable. Incluye, pero no está limitado a las siguientes situaciones:

1. Ingestión de tóxicos o sobredosis de fármacos con potencial descompensación aguda de órganos o sistemas vitales
2. Síndrome de disfunción o fallo multiorgánico
3. Trombocitopenia asociada a fallo multiorgánico
4. Hipertermia maligna sospechada o documentada
5. Lesiones por corriente eléctrica y otras domésticas o ambientales
6. Casi-ahogamiento
7. Quemaduras que cubran 20% de la superficie corporal
8. Evidencia o signos sugerentes de la existencia de hipoxia tisular sistémica
9. Hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal

Necesidad de aplicar tecnologías o procedimientos invasivos especializados

Condiciones clínicas en las que el paciente necesite de tecnologías o procedimientos asistenciales especializados, monitorización, intervenciones complejas o tratamiento, incluyendo medicación y que por el

riesgo o complejidad inherente a su aplicación o por el estado de enfermedad del paciente excedan la capacidad institucional para su cuidado fuera de la UPSS Cuidados Intensivos; de carácter invasivo o no invasivo.



ANEXO N°9
PRIORIDADES DE ADMISIÓN A LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Marco de admisión a la UPSS Cuidados Intensivos		
Unidades de la UPSS Cuidados Intensivos	**Prioridad**	**Tipo de paciente crítico**
Unidad de Cuidados Intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos.	Prioridad 1	Pacientes críticos que requieren soporte vital por insuficiencia orgánica, monitorización intensiva, o terapias proporcionadas únicamente en el entorno de la UPSS Cuidados Intensivos. Estos pacientes tienen gran probabilidad de recuperación. El soporte vital incluye ventilación mecánica invasiva, ventilación prona, terapias de reemplazo renal, monitorización hemodinámica invasiva, oxigenación por membrana extracorpórea, bombas con balón intraaórtico y otras situaciones que requieren cuidados críticos (p. ej., pacientes con hipoxemia grave o en shock).
Unidad de Cuidados Intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos.	Prioridad 2	Pacientes, como se describió en la prioridad 1, con una probabilidad de recuperación significativamente menor y que desea recibir terapias de cuidados intensivos, pero no de reanimación cardiopulmonar en caso de paro cardíaco (p. ej., pacientes con cáncer metastásico e insuficiencia respiratoria severa o en shock séptico que requieren vasopresores).
Unidad de Cuidados Intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos.	Prioridad 3	Pacientes con disfunción orgánica que requieren monitorización y/o terapias intensivas (p. ej. Ventilación no invasiva), o que, en la opinión clínica del médico o comité de ética que atiende la interconsulta, podrían ser tratados en un nivel de atención de salud menor a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero bajo vigilancia médica (p. ej., pacientes postoperados que requieren una estrecha vigilancia por el riesgo de deterioro o que requieren cuidados postoperatorios intensos, pacientes con problemas respiratorios). Es posible que estos pacientes sean admitidos en la UPSS Cuidados Intensivos si el tratamiento temprano no logra prevenir el deterioro o si no hay capacidad en la unidad de cuidados intermedios del establecimiento de salud.
Unidad de Cuidados Intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos	Prioridad 4	Pacientes con características clínicas semejantes a la Prioridad 3, pero con menor probabilidad de recuperación/supervivencia (p. ej., pacientes con enfermedad metastásica subyacente) y, que no desean ser intubados o reanimados. Si el establecimiento de salud no tiene capacidad en la unidad de cuidados intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos, estos pacientes podrían ser considerados para la unidad de cuidados intensivos en circunstancias especiales.
Cuidados Paliativos	Prioridad 5	Pacientes con enfermedad terminal (o moribundos) sin posibilidad de recuperación; estos pacientes, en general, no serían aptos para el ingreso a las unidades de cuidados intensivos (a menos que sean posibles donantes de órganos). En los casos en los que los individuos han rechazado inequívocamente las terapias de cuidados intensivos o tienen procesos irreversibles como el cáncer metastásico sin opciones adicionales de quimioterapia o radioterapia, se deben ofrecer inicialmente cuidados paliativos.
Fuente: Traducido y adaptado de: Joseph L. Nates, Mark Nunnally, MD, Ruth Kleinpell, Sandralee Blosser, Jonathan Goldner, Barbara Birriel, Clara S. Fowler, Diane Byrum, William Scherer Miles, Heatherlee Bailey, Charles L. Sprung. (2016). Directrices de admisión, alta y clasificación en la UCI: un marco para mejorar las operaciones clínicas, el desarrollo de políticas institucionales y futuras Investigaciones. Critical Care Medine 44(8): pág. 1553-1608.		

C. ALVARADO CH.

ANEXO N°10

HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Nivel	Tipo de Paciente	Ratio Profesional en Enfermería / Paciente	Intervenciones
Cuidados Intensivos (muy alto o nivel 3)	Paciente críticamente enfermo que necesita monitoreo horario y/o invasivo, tal como monitoreo de la PA vía línea arterial.	1:1 a ≤ 1:2	Intervenciones invasivas no realizadas en ningún otro lugar del establecimiento de salud, tales como drenaje de fluido neuro espinal para manejo de presión intracraneal elevada, ventilación mecánica etc.
Cuidados Intermedios (alto-medio o nivel 2*)	Pacientes inestables que necesitan intervenciones de enfermería, exámenes de laboratorio y/o cada 2-4 horas	≤ 1:3	Intervenciones tales como ventilación no invasiva, infusiones intravenosas, titulación de vasodilatadores o sustancias antiarrítmicas
Telemetría/ Cuidados Intensivos Extendidos (medio-bajo o nivel 1*)	Pacientes estables que necesitan monitoreo electrocardiográfico estrecho para arritmias no malignas, o exámenes de laboratorio cada 2-4 horas. Este tipo de servicio es principalmente para propósitos de monitoreo.	≤ 1:4	Infusión intravenosa y titulación de medicaciones tales como vasodilatadores o antiarrítmicos
UPSS hospitalización (bajo o nivel 0)	Pacientes estables que necesitan evaluación y monitoreo no más frecuentes que cada 4 horas	≤ 1:5	Antibióticos intravenosos, quimioterapia intravenosa, exámenes de laboratorio y radiológicos como plan de diagnóstico

*Si un establecimiento no tiene este nivel, el paciente debe ser admitido en el siguiente nivel más alto.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO N°11

RECOMENDACIONES GENERALES EN CONDICIONES DE SOBREDEMANDA EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS CAUSADA POR EMERGENCIA MASIVA O DESASTRE[7]

RELACIONADA CON EL RECURSO		RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS PERSONA/SITUACIÓN GLOBAL		RELACIONADOS CON LA ETICA DE LAS DECISIONES	
	RECOMENDACIÓN		**RECOMENDACIÓN**		**RECOMENDACIÓN**
PLAN DE CONTINGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON ÉNFASIS EN CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS	Disponer de un plan de contingencia que planifique la distribución de pacientes en áreas específicas del establecimiento de salud.	**VALORACIÓN DE LA PERSONA**	Valorar el paciente de forma global y no de forma aislada	**RESULTADOS**	En condiciones de crisis y respetando los principios éticos al priorizar:
	Valorar la posibilidad de referencia a otro establecimiento de salud, si el paciente cumple con criterios de reversibilidad e idoneidad de ingreso a Cuidados Intensivos.		Valorar el aspecto de "edad biológica" (grado de fragilidad, multimorbilidad), más allá de la "edad cronológica"		La maximización de la supervivencia al alta del establecimiento de salud. La maximización de las posibilidades de vivir en cada una de las etapas de la vida.
	Ampliar la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos, facilitando ingresos en otras áreas habilitadas en contexto de emergencia masiva o desastre con recursos adecuados.		Conocer los valores y preferencias de la persona, consultando si dispone de voluntades anticipadas o si existe un plan de cuidados anticipados y seguir sus instrucciones		La edad cronológica en años **no debe ser el único elemento a considerar** en las estrategias de asignación
	Solidaridad entre los establecimientos de salud para maximizar el bien común por encima del bien individual.				
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES	Restringir los ingresos condicionados a pruebas terapéuticas e ingresos con intensidad terapéutica máxima	**PRIORIZACIÓN DE LAS PERSONAS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL**	Considerar los criterios regulares de ingreso a cuidados intensivos e intermedios según el modelo de 5 prioridades	**TRIAJE BASADO EN LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA**	Principio costo/oportunidad: Considerar que admitir un ingreso puede implicar denegar el ingreso a otra persona que tiene mayores probabilidades de sobrevida en base a score de falla de multiorgánica.

[7] Fuente: Semicyuc. (2020). Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia Covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos. En: https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/Ética_SEMICYUC-COVID-19.pdf.

RELACIONADA CON EL RECURSO		RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS PERSONA/SITUACIÓN GLOBAL		RELACIONADOS CON LA ETICA DE LAS DECISIONES	
	Priorizar los procedimientos que faciliten y promuevan la liberación del ventilador mecánico		Se priorizará los ingresos a las unidades de cuidados intensivos a pacientes clasificados como Prioridad 1.		Aplicar criterios de ingreso a Cuidados Intensivos maximizando el beneficio.
	Facilitar el flujo de pacientes de las unidades de cuidados intensivos e intermedios hacia la UPSS Hospitalización con la finalidad de dar pase a ingresos nuevos de pacientes críticos		Los pacientes clasificados como prioridad 3 podrán pasar a unidades de cuidados intermedios dependiendo de la disponibilidad de cama, recursos disponibles y existencia o no de sobredemanda por emergencia masiva o desastre. Considerar que las camas de las unidades de cuidados intermedios se pueden convertir en camas de cuidados intensivos dependiendo de la sobredemanda, por lo cual pacientes con prioridades 3 y 4 son restringidos para pase a unidades de cuidados intensivos e intermedios bajo estas circunstancias		Estos principios se deberían aplicar de manera uniforme a todas las personas y no de forma selectiva a los de perfil geriátrico o con patologías crónicas
	Restringir el ingreso de pacientes que han dejado por escrito voluntades anticipadas o cuyos pacientes han manifestado en forma expresa su rechazo a cuidados intensivos y ventilación mecánica				
CONSENSO DE LOS CRITERIOS A APLICAR	La modificación temporal y excepcional de los criterios de ingreso debe ser compartida por todos los involucrados en el proceso respetando los principios bioéticos.	**ADECUACIÓN DE LA INTENSIDAD TERAPÉUTICA SEGUN LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE**	Establecer desde el ingreso un plan de adecuación terapéutica y documentarlo en la historia clínica con definición clara de si existe o no indicación de ventilación mecánica.	**PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD**	En personas en las que se prevée un beneficio mínimo como situaciones de fracaso multiorgánico establecido, riesgo de muerte estimado por escalas de gravedad como APACHE o SOFA o situaciones funcionales muy limitadas, condiciones de fragilidad evidentes se limita el ingreso. **E** Valorar el beneficio de ingreso de pacientes con menor expectativa de vida establecida mediante herramienta NECPAL o similar.



RELACIONADA CON EL RECURSO		RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS PERSONA/SITUACIÓN GLOBAL		RELACIONADOS CON LA ETICA DE LAS DECISIONES	
PLANIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS	En el caso de desestimar el ingreso de un paciente a cuidados intensivos o intermedios se debe de ofrecer alternativas asistenciales de calidad que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y sus familias incluyendo el soporte psicoemocional y control sintomático.		En caso de mala evolución del paciente con cuidados intensivos se debe plantear una des intensificación terapéutica sin dilatación e iniciar medidas paliativas. En este caso es pertinente derivar al paciente a un área de menor complejidad garantizando un plan de atención paliativa.	**TRANSPAR EN-CIA Y CONFIANZA**	Se debe comunicar a pacientes / familiares lo extraordinario de la situación y la justificación de las medidas propuestas.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO N°12

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS *

Fecha: .....**Turno:** (D) (N).....**Hora**.....

Médico cirujano especialista en medicina intensiva (o Médico cirujano de la especialidad de: medicina interna, cardiología, anestesiología, neumología, medicina de emergencias y desastres, capacitado en cuidados intensivos en los casos que contempla el numeral 5.10).

Nombre: .....

Especialidad: .....

RNE (registro nacional de especialista) .....

I. Pacientes

Ítems	N°
1. Camas ocupadas.	
2. Ingresos en el turno.	
3. Reingresos en el turno.	
4. Salidas de la UPSS CI.	
5. Fallecidos.	
6. Otro:	

II. Procedimientos Médicos Invasivos

Procedimiento	Tipo	Acceso	Intentos	Complicación
Colocación de Catéter central.				
Colocación de Catéter arterial.				
Colocación de Marcapaso externo.				
Colocación de Swan Ganz				
Colocación de Tubo Oro Traqueal.				
Punción lumbar.				
Toracocentesis.				

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

Toracotomía.				
Paracentesis.				
Pericardiocentesis.				
Hemocultivo.				
Mielocultivo.				
Peritoneo diálisis.				
Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral.				
Nutrición Parenteral.				
Cardioversión.				
Traqueostomía.				
Extubación.				
Otro:				

C. ALVARADO CH.

III. Actividades Cuidados Intensivos extendidos

Actividad	N°
1. Interconsultas.	
2. Colocación de Tubo Oro Traqueal.	
3. Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral.	
4. Colocación de Catéteres (especificar).	
5. Ultrasonido.	
6. Otro:	

IV. Equipo para Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral

- Número de Equipos:
- Operativo (SI) (NO)

V. Registro de APACHE II

Camas:	Valor
Promedio	

VI. TISS

VI. Registro de TISS

Cama	Valor
Promedio	

VII. Eventos adversos (Reporte en formato establecido)

.....

.....

.....

.....

VIII. Demanda Insatisfecha

.....

.....

.....

Para los establecimientos de salud que disponen de sistema informático y/o sistematizado, estos parámetros serán registrados en los sistemas disponibles como historia clínica electrónica o informática, módulo de interconsultas u otros que haya desarrollado la UPSSS Cuidados Intensivos en coordinación con la Oficina de Estadística e Informática del establecimiento de salud.

ANEXO N°13

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

I. Pacientes

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Camas ocupadas:	Pacientes que están internados al final del Turno
Ingresos:	Pacientes Ingresados durante el turno
Re – Ingresos:	Ingresos que se indica su salida de UPSS CI en los 4 días previos al reingreso
Salidas de la UPSS CI:	Pacientes que salen de la UPSS CI durante el turno
Fallecidos *	Pacientes fallecidos durante el turno

II. Procedimientos Médicos Invasivos
Detalle de procedimientos médicos realizados dentro de la UPSS Cuidados Intensivos.

III. Actividades Cuidados Intensivos extendidos
Detalle de procedimientos médicos realizados fuera de la UPSS Cuidados Intensivos.

IV. Equipo Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral
Operativo / No operativo. Detallar

V. APACHE II
Valor de APACHE II de los pacientes ingresados durante el turno.

VII. TISS
Valoración según Escala TISS de los pacientes presentes al final del turno.

VIII. Eventos adversos:
Reporte en formato establecido con el equipo de gestión de calidad del establecimiento de salud y de la UPSS Cuidados Intensivos.

IX. Demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha en cuidados intensivos es cuando se supera la oferta de atención conduciendo al racionamiento de este recurso tan costoso y limitado.

C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 14

MODELO DE FORMATO DE JUNTA MÉDICA DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Siendo las: .....del día ...de.....del 202...los médicos cirujanos convocados en la sala de reuniones de la UPSS Cuidados Intensivos del Establecimiento de Salud ..... realizan la Junta Médica a solicitud de: .....

I. **Integrantes**:

1. Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.....
2. Médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia. .....
3. Médicos cirujanos de especialidades quirúrgicas..... .....
4. Médicos cirujanos de especialidades Médicas..... .....
5. Paciente/ Representante / Familiar

II. **Del Paciente:**

APELLIDOS **NOMBRES**

.....

DNI N°.....**UNIDAD: .....CAMA:** .....

III. **Diagnósticos de Ingreso:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....



C. ALVARADO CH.

IV. **En la actualidad cursa con los siguientes Problemas Diagnósticos:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

V. **Siendo su Estado actual:**

- .....
- .....
- .....

VI. **Definiendo su Pronóstico:**

- .....
- .....
- .....

- .....

VII. Conclusiones

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

VIII. Recomendaciones:

Esta junta recomienda que el/la paciente se proceda a.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

C. ALVARADO CH.

Los resultados de la junta serán comunicados al representante y/o familiar(es) y se consigne en la Historia Clínica la realización de la presente Junta Médica.

Siendo las .....del Día .... de...del 202...y dando fe firman los médicos cirujanos presentes en la Junta Médica (firma y sello).

....

....

Solicitud: oral trascrita en Historia Clínica. Preferentemente escrita y firmada Representante (Fecha, hora, DNI, apellidos y nombres completos).

ANEXO N° 16

PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales	Atención en Sala de Cuidados Intensivos Generales, por médico cirujano especialista en medicina intensiva y equipo interdisciplinario a pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad permanente, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Generales	Atención en Sala de Cuidados Intermedios General, por médico cirujano especialista en medicina intensiva y equipo interdisciplinario, a pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad; pero que su estado aún reviste gravedad, y que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en Cuidados Intensivos Extendidos a pacientes en estado crítico fuera de la UPSS Cuidados Intensivos	Atención a pacientes en estado crítico, en el marco de la continuidad de atención del paciente crítico, en el lugar y contexto de origen (UPSS Hospitalización o UPSS Emergencia), que no pueden acceder a la UPSS Cuidados Intensivos por falta de disponibilidad de cama. Esta atención se comparte por responsabilidad con el personal médico cirujano de la UPSS de origen del paciente.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	Atención en Sala de Cuidados Intensivos Neonatal, por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría, capacitado en cuidados intensivos, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal y equipo interdisciplinario de salud, a neonatos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad permanente, que requieren atención especializada durante las 24 horas del día. Incluye atención para neonatos aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales	Atención en Sala de Cuidados Intermedios Neonatal, por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría, capacitado en cuidados intensivos, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal y equipo interdisciplinario, a neonatos críticamente enfermos en condición de estabilidad; pero que su estado aún reviste gravedad, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a neonatos aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos	Atención en Sala de Cuidados Intensivos Pediátricos, por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica a pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad permanente, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes pediátricos aislados.

C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 15

CONSIDERACIONES PARA LA NOTA DE EGRESO DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

A. Criterios Generales

1. Resolución del problema que motivo el ingreso del paciente a la UPSS Cuidados Intensivos.
2. Imposibilidad de resolver el problema en la UPSS Cuidados Intensivos.
3. Defunción.

B. Criterios Específicos – Seguridad y Riesgo

1. La estancia en la UPSS Cuidados Intensivos será la mínima necesaria.
2. Las circunstancias de egreso pueden ser:
   a) Programadas.
   b) No programadas.
   c) No previstas.
   d) Por defunción.
3. El médico cirujano especialista en medicina intensiva comunica la decisión de egreso al médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, y ambos elaboran el Plan de las condiciones de vigilancia del tratamiento que debe realizarse durante el traslado a la unidad de cuidados intermedio o a la UPSS de procedencia.
4. El Médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos comunica al médico cirujano que conduce la gestión clínica de la UPSS de destino del paciente, acerca del traslado y las condiciones clínicas del paciente; dando pase al paciente y haciendo entrega de su expediente clínico.
5. La transferencia a sala de operaciones de la UPSS Centro Quirúrgico se realiza de acuerdo a las coordinaciones previas, según las siguientes especificaciones:
   a) En forma conjunta, médico cirujano especialista en cirugía general y el médico cirujano especialista en anestesiología acuerdan el Plan de vigilancia y tratamiento transoperatorio.
   b) El médico cirujano tratante y el médico cirujano especialista en medicina intensiva comunican al paciente, familiar, o a su representante, la indicación quirúrgica y sus riesgos.
   c) El traslado es responsabilidad del médico cirujano especialista en medicina intensiva y del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos, quienes determinan los cuidados necesarios para minimizar los riesgos.

MINISTERIO DE SALUD Aseguramiento e Intervenciones Prestacionales Dirección General de C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos	Atención en Sala de Cuidados Intermedios Pediátrico, por médico cirujano especialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica y equipo interdisciplinario de salud, a pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de estabilidad; pero que su estado aún reviste gravedad, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes pediátricos aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de otras especialidades médicas y quirúrgicas (especificar)	Atención en sala de cuidados intensivos de especialidades (especificar: cardiológica, neuroquirúrgica, oncológica, de ginecología y obstetricia, ginecológica, obstétrica, de cirugía de tórax y cardiovascular, de quemados, entre otras) por médico cirujano de la especialidad correspondiente (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos, o médico cirujano especialista en medicina intensiva con entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad correspondiente (especificar) y equipo interdisciplinario de salud, a pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad permanente, que requieren atención especializada durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios de otras especialidades médicas y quirúrgicas (especificar)	Atención en sala de cuidados intermedios de Especialidades (especificar: cardiológica, neuroquirúrgica, oncológica, de ginecología y obstetricia, ginecológica, obstétrica, de cirugía de tórax y cardiovascular, de quemados, entre otras) por médico cirujano de la especialidad correspondiente (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos o por médico cirujano especialista en medicina intensiva con entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad correspondiente (especificar) y equipo interdisciplinario de salud, a pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste gravedad. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la unidad de cuidados intensivos general diferenciada para COVID-19 u otra pandemia	Atención en sala de cuidados intensivos general diferenciada para COVID-19, u otra pandemia, por médico cirujano especialista en medicina intensiva y equipo interdisciplinario, a pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención de Soporte Nutricional Parenteral Total para pacientes	Atención con fórmulas parenterales por médico cirujano especialista en medicina intensiva, con apoyo de profesional en enfermería especialista, capacitados en soporte nutricional a pacientes críticamente enfermos en sala de cuidados intensivos y sala de cuidados intermedios, que requieren de soporte nutricional parenteral total de acuerdo a necesidad.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención de Soporte Respiratorio en alto flujo, ventilación mecánica invasiva o no invasiva o post ventilación mecánica	Atención con intervención en la programación de alto flujo, ventilación mecánica o protocolos de destete/decanulación con sin terapia farmacológica adyuvante por médico cirujano especialista en medicina intensiva, con apoyo de profesional en enfermería especialista, capacitados en soporte respiratorio avanzado a pacientes críticamente enfermos en sala de cuidados intensivos y sala de cuidados intermedios u UPSS Hospitalización que requieren de evaluación para toma de decisiones en el soporte ventilatorio artificial o retiro del mismo de acuerdo a necesidad.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Junta médica en cuidados intensivos	Atención de salud (consulta u opinión médica) realizada por dos o más médicos cirujanos de distintas especialidades o subespecialidades con participación del médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, según corresponda, que se constituyen para la toma de decisión conjunta respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, generales o de especialidades, solicitada por el médico cirujano tratante; en ambiente específico donde se comparte, revisa y se discute la información clínica de la historia clínica.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Telejunta médica en cuidados intensivos	Atención de salud (consulta u opinión médica) a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por dos o más médicos cirujanos de distintas especialidades o subespecialidades médicas del establecimiento de salud o de otros establecimientos de salud, en ambiente específico, para la toma, en conjunto, de decisión médica respecto el diagnóstico, terapéutica y pronóstico de un paciente en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, generales o de especialidades, a solicitud del médico cirujano tratante.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos generales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en medicina intensiva a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intensivos de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.

MINISTERIO DE SALUD
C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios generales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico especialista en medicina intensiva a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intermedios de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos neonatales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría, capacitado en cuidados intensivos, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal a médico especialista de una unidad de cuidados intensivos de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de neonatos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios neonatales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría, capacitado en cuidados intensivos, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal a médico especialista de una unidad de cuidados intermedios de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de neonatos enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste de gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intensivos de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios pediátricos	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intermedios de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos de especialidades (especificar)	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista (especificar) con subespecialidad (especificar) y con capacitación y entrenamiento en cuidados intensivos (especificar) o médico cirujano especialista en medicina intensiva o médico cirujano especialista (especificar) que desarrolla servicio de salud subespecializado (especificar) o médico cirujano especialista (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos (especificar) a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intensivos de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios de especialidades (especificar)	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista (especificar) con subespecialidad (especificar) y con capacitación y entrenamiento en cuidados intensivos (especificar) o médico cirujano especialista en medicina intensiva o médico cirujano especialista (especificar) que desarrolla servicio de salud subespecializado (especificar) o médico cirujano especialista (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos (especificar) a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intermedios de especialidades; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste de gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleseguimiento en la unidad de cuidados intensivos generales	Seguimiento en la atención de salud o monitoreo clínico a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en medicina intensiva para identificación de signos de alarma, señales biológicas por medio de sensores, entre otros, de pacientes en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, mediante la transferencia de información clínica o parámetros biomédicos o exámenes auxiliares, que se pueden transmitir a una ubicación remota al médico cirujano especialista; en ambiente específico.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleseguimiento en la unidad de cuidados intensivos pediátricos	Seguimiento en la atención de salud o monitoreo clínico a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica o médico cirujano especialista en pediatría que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica para identificación de signos de alarma, señales biológicas por medio de sensores, entre otros, de pacientes en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, mediante la transferencia de información clínica o parámetros biomédicos o exámenes auxiliares, que se pueden transmitir a una ubicación remota al médico especialista; en ambiente específico.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleseguimiento en la unidad de cuidados intensivos de especialidades (especificar)	Seguimiento en la atención de salud o monitoreo clínico a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en medicina intensiva con capacitación y entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad correspondiente (especificar) o médico cirujano de la especialidad correspondiente (especificar) con capacitación y entrenamiento en cuidados intensivos para identificación de signos de alarma, señales biológicas por medio de sensores, entre otros, de pacientes en estado crítico, mediante la transferencia de información clínica o parámetros biomédicos o exámenes auxiliares, que se pueden transmitir a una ubicación remota al médico especialista; en ambiente específico de la sala de cuidados intensivos de especialidades (especificar: cardiológica, neuroquirúrgica, oncológica, de ginecología y obstetricia, ginecológica, obstétrica, de cirugía de tórax y cardiovascular, de quemados, entre otras) .

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 17

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS[8]

N°	Codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios	Procedimiento Médico
1	01999	Procedimiento de anestesia/analgesia que no aparece en la Lista, por ejemplo: hipnosis de medicamentos, hipnosis y analgesia de medicamentos, terapia del dolor (seguimiento)
2	15852.01	Curación de lesiones por presión
3	15859	Retiro de catéter (CVP, CVC, SF, SNG, SOG u otros)
4	15882	Curación de catéter venoso central (CVC)
5	15886	Curación de úlcera de decúbito III
6	31500	Intubación endotraqueal, procedimiento de emergencia, urgencia o electivo
7	31500.01	Intubación endotraqueal asistida con fibroscopio (reutilizable, descartable, rígido y/o flexible)
8	31500.02	Intubación endotraqueal asistida con video laringoscopio
9	31502	Cambio de tubo de traqueostomía anterior al establecimiento de tracto fistuloso
10	31600	Traqueostomía, planificada (procedimiento separado)
11	31603	Traqueostomía, procedimiento de emergencia; transtraqueal
12	31605	Traqueostomía transtraqueal de emergencia a través de membrana de cartílago cricotiroideo
13	31615	Broncoscopia a través de Incisión de traqueostomía establecida

C. ALVARADO CH.

[8] Para la atención de salud del paciente en estado crítico existen más procedimientos médicos que pueden realizarse según necesidad.

N°	Codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios	Procedimiento Médico
14	31645	Broncoscopía, incluyendo guía fluoroscópica, cuando se realice, con aspiración terapéutica del árbol bronquial (p.ej.: drenaje de absceso pulmonar), procedimiento inicial
15	31720	Aspiración nasotraqueal con catéter
16	31720.01	Aspiración de secreciones
17	31720.02	Aspiración de secreciones por circuito cerrado o continua
18	31725	Aspiración traqueobronquial con catéter y fibroscopio, en cama de internamiento (procedimiento separado)
19	31820.01	Curación de traqueostomía
20	32036	Toracostomía; con drenaje a través de colgajo abierto, por empiema
21	32561	Instilación(es) vía catéter/tubo torácico de agente de fibrinolisis (p. ej. agente fibrinolítico para el manejo de un derrame multilobulado); día inicial
22	33010	Pericardiocentesis inicial
23	33212	Inserción (solamente) de generador de pulsos marcapasos; con terminal único ya existente
24	36489	Colocación de catéter venoso central (p. ej. para presión venosa central, quimioterapia, otros)
25	36597	Reposicionamiento de catéter venoso central previamente colocado bajo guía fluoroscópica
26	43870.01	Curación de gastrostomía
27	49083	Paracentesis abdominal (diagnóstica o terapéutica); con orientación de imágenes

N°	Codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios	Procedimiento Médico
28	61260	Cateterismo cerebral subdural para medir la presión intracraneal
29	62270	Punción lumbar, diagnóstica o terapéutica
30	76930	Orientación ecográfica para pericardiocentesis, Supervisión e interpretación de imágenes
31	82803	Dosaje de Gases en sangre, cualquier combinación de pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 (incluyendo la saturación de O2 calculada)
32	82803.01	Dosaje de gases arteriales y electrolitos (dispositivo portátil)
33	90947	Diálisis, con excepción de hemodiálisis (p. ej. diálisis peritoneal, hemofiltración, u otras terapias renales continuas del reemplazo), que requiere repetida(s) Evaluación(es) médica(s) que requiere evaluaciones repetidas por médico u otro profesional de la salud calificado, con o sin revisión sustancial de la prescripción de diálisis
34	92950	Reanimación cardiopulmonar (p. ej. en paro cardiaco)
35	92960	Cardioversión electiva, conversión eléctrica de la arritmia, externa
36	92961	Cardioversión electiva, conversión eléctrica de la arritmia, interna (procedimiento separado)
37	93236	Control electrocardiográfico durante 24 horas por control computadorizado continuo y registro no continuo, y análisis de los datos en tiempo real mediante un dispositivo capaz de producir un trazado de tamaño completo de las ondas, que podría control y análisis de datos en tiempo real, con informe
38	93542	Cateterismo venoso central
39	93882.03	Estudio Doppler carotídeo + transcraneal
40	93882.05	Protocolo de arresto circulatorio

C. ALVARADO CH.

N°	Codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios	Procedimiento Médico
41	93886	Estudio transcraneal Doppler de las arterias intracraneales; estudio completo
42	94002	Asistencia y manejo de ventilación, inicio de ventiladores de presión o de volumen predefinidos para respiración asistida o controlada; en paciente bajo observación/internamiento, día inicial
43	94003	Asistencia y manejo de ventilación, inicio de ventiladores de presión o de volumen predefinidos para respiración asistida o controlada; en paciente bajo observación/internamiento, cada día subsiguiente
44	94315	Registro de Espirometría, grabación (incluye Colocación, educación, transmisión y captura de datos, análisis de tendencias y recalibración periódica)
45	94644	Tratamiento con inhalación continua de medicamento en aerosol para obstrucción aguda de las vías aéreas; primera hora
46	94645	Tratamiento con inhalación continua de medicamento en aerosol para obstrucción aguda de las vías aéreas; cada hora adicional (registrar por separado adicionalmente al código primario de atención)
47	94656	Ayuda y manejo de la ventilación, inicio de ventiladores de presión o de volumen prefijados para la respiración asistida o controlada
48	94657	Restablecimiento de valores de presión o volumen para ventilación asistida o controlada cada uno de los días subsecuentes de soporte ventilatorio
49	94660	Inicio y manejo de ventilación con presión positiva continua en las vías aéreas
50	94662	Inicio y manejo de ventilación con presión negativa continua
51	94762	Oximetría no invasiva de la oreja o de pulso para determinar saturación de oxígeno; mediante monitoreo continuo durante toda la noche (procedimiento separado)
52	94770	Colección y análisis de gas espirado para medición de CO2 mediante analizador infrarrojo

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

N°	Codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios	Procedimiento Médico
53	95961	Mapeo funcional cortical y subcortical mediante estimulación y/o registro de electrodos sobre superficie cerebral, o proveniente de electrodos en profundidad, para provocar convulsiones o identificar estructuras cerebrales vitales; hora inicial de asistencia por médico u otro profesional de la salud calificado
54	97799.01	Fisioterapia respiratoria
55	97799.02	Fisioterapia cardiovascular
56	99141	Sedación con o sin analgesia (sedación consciente); intravenosa, intramuscular o por inhalación
57	99141.01	Sedación con o sin analgesia (sedación consciente); por inhalación para-TEM
58	99188	Colocación de sonda naso yeyunal para soporte nutricional enteral
59	99188.01	Colocación de sonda orogástrica/nasogástrica
60	99199.43	Preparación de mezclas parenterales y enterales especializadas
61	99218	Monitoreo de soporte nutricional/día
62	99255	Interconsulta para la evaluación y manejo de un paciente nuevo o continuador que se encuentra hospitalizado en un establecimiento de salud donde recibe cuidados intensivos
63	99263	Día paciente en hospitalización de cuidados intermedios (incluye admisión y salida de ésta)
64	99291	Evaluación y manejo de un paciente críticamente enfermo en UCI. Este código está reservado para los primeros 30-74 minutos de manejo
65	99291.01	Servicios de cuidados críticos brindados por médico, cara a cara, durante un transporte asistido de paciente adulto en estado crítico o críticamente lesionado, monitoreo; primeros 30-74 minutos de atención directa durante el transporte
66	99292	Evaluación y manejo de un paciente críticamente enfermo. Este código está reservado para los primeros 30-74 minutos de manejo. Este código está reservado para cada uno de los siguientes 30 minutos adicionales. de manejo. Se debe registrar adicionalmente al código principal

MINISTERIO DE SALUD Aseguramiento e Intercambios Prestacionales Dirección General C. ALVARADO CH.

N°	Codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios	Procedimiento Médico
67	99295	Atención en unidad de cuidados intensivos, día paciente.
68	99295.06	Mantenimiento del donante cadavérico (atención en unidad de cuidados intensivos; paciente en muerte encefálica, día paciente).
69	99299	Monitoreo de soporte ventilatorio invasivo/día.
70	99300	Monitoreo de soporte ventilatorio no invasivo/día.
71	99301	Monitoreo de gasto cardiaco invasivo/día.
72	99301.01	Monitoreo de presión arterial invasiva.
73	99301.02	Monitoreo de la presión de la arteria pulmonar
74	99305	Atención paciente-día cuidados intermedios
75	99443	Transporte asistido de paciente o herido en estado crítico o de alto riesgo que requieren asistencia médica avanzada durante el traslado
76	99443.01	Transporte asistido de paciente o herido en estado crítico o de alto riesgo que requieren asistencia médica avanzada durante el traslado; este código está reservado para cada uno de los siguientes 30 minutos adicionales de transporte; se debe registrar adicionalmente al Código principal.
77	99562	Nutrición parenteral por día

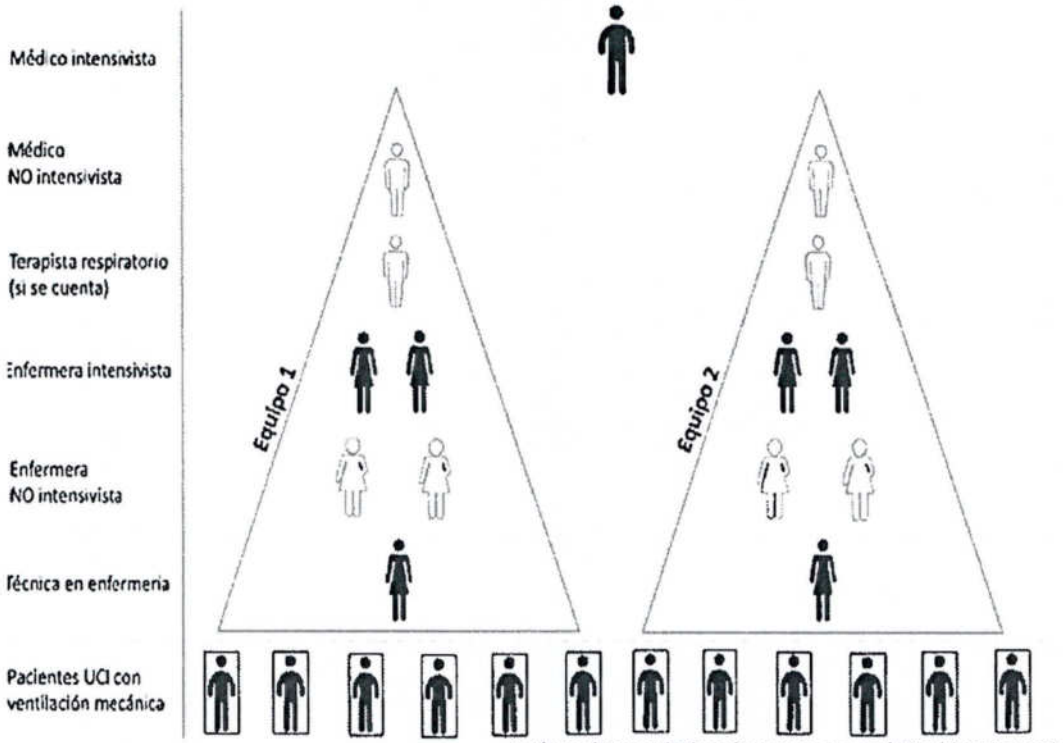
✓ Según necesidad del paciente, condición o grupo etario, se incluyen otros procedimientos médicos.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

ANEXO N° 18

SISTEMA DE ATENCIÓN ESCALONADO O PIRAMIDAL PARA USO EN CASOS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, DE EMERGENCIA SANITARIA O DEBIDO A UNA CRISIS SANITARIA POR PANDEMIA.[9]

UN INTENSIVISTA CON 02 EQUIPOS



Las figuras del personal rellenas de negro en un equipo (triángulo), es el personal habitual en una UCI de 6 camas, con un Médico intensivista. Las figuras no sombreadas, son de personal de apoyo de otros servicio en desastres.

C. ALVARADO CH.

[9] Adaptado de SCCM. United States Resource Availability for COVID-19. 2021. Disponible en: https://sccm.org/getattachment/Blog/March-2020/United-States-Resource-Availability-for-COVID-19/United-States-Resource-Availability-for-COVID-19.pdf?lang=en-US.

Norma Técnica de Salud Nro 181-2022-MINSA/DGIESP. "Manejo de personas afectadas por COVID-19 en áreas de atención críticas de adultos". En: RM Nro 094-2022-MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/2768312-094-2022-minsa.

IX. BIBLIOGRAFÍA.

1. American Heart Association. Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider Manual. Dallas, TX: American Heart Association; 2020.
2. American Heart Association. Basic Life Support (BLS) Provider Manual. Dallas (TX): American Heart Association; 2020.
3. Asensio M, Hernández B, Yus T y Minvielle A. Infeciones en el paciente crítico. Rev. Medicine (Madr). 2018 12(52):3085-3096.
4. Busicoa M, Nevesb A, Carini F, et al. Programa de seguimiento al alta de la unidad de cuidados intensivos. Med Intensiva. 2019;43(4):243---254.
5. Costa DK, Wallace DJ, Kahn JM. The Association Between Daytime Intensivist Physician Staffing and Mortality in the Context of Other ICU Organizational Practices: A Multicenter Cohort Study. Crit Care Med. 2015 nov; 43(11):2275-2282.
6. Díaz Y. UCI Extendida seguimiento de los pacientes críticos al alta del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Mar. Tesis Doctoral; Universidad Autónoma de Barcelona 2019.
7. Escudero D, Viña L, y Clementina C. Por una UCI de puertas abiertas, más confortable y humana. Es tiempo de cambio. Rev. Medicina intensiva 2014 (6): 371-375.
8. Galarce F, Espinoza M, Zamorano G, Ceballos P. Servicios de Extensión de Cuidados Críticos: Implicancias para Enfermería. Rev. Enfermería Actual de Costa Rica. 2018; 35: 173-184.
9. Giannasi, S. E., Venuti, M. S., Midley, A. D., Roux, N., Kecskes, C., & San Román, E. Factores de riesgo de mortalidad de los pacientes ancianos en cuidados intensivos sin limitación del esfuerzo de tratamiento. Medicina Intensiva, 42(8), 482–489.
10. Rawal G, Yadav S, Kumar R. Post-intensive Care Syndrome: an Overview. J Transl Int Med. 2017 jun 30;5(2):90-92.
11. Reis Miranda D, Nap R, De Rijk A, et al: Nursing Activities Score. Crit CAre Med 2003; 31(2): 374-382
12. Reis Miranda D, Moreno R, Iapichino G.: Nine equivalents of nursing manpower use score (NEMS). Intensive Care Medicine 1997; 23: 760-765
13. Scales D, Rubenfeld G. The Organization of Critical Care: An Evidence-Based Approach to Improving Quality. 1ed. Springer eBooks. 2014.
14. Weled B, Adzhigirey L. Critical Care Delivery: The Importance of Process of Care and ICU Structure to Improved Outcomes: An Update from the American College of Critical Care Medicine Task Force on Models of Critical Care. Critical Care Medicine. 2015 jul; 43(7):1520-1525.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.